

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE

ANNEE UNIVERSITAIRE 2025-2026

**CHU Constantine**

**Service d'Hépto-Gastro-Entérologie**

# **Tuberculose digestive**

**Dr R. DJEBBAR**

**Maitre assistante en hépto-gastro-entérologie**

## **Plan du cours :**

- I. Introduction
  - Définition
  - Intérêt de la question
- II. Épidémiologie
- III. Etiopathogénie
- IV. Tuberculose intestinale
- V. Tuberculose péritonéale
- VI. Autres formes
- VII. Diagnostic différentiel
- VIII. Traitement
- IX. Conclusion

# **I. Introduction :**

## **1. Définition :**

La tuberculose (TB) est une maladie infectieuse causée par le **Mycobacterium tuberculosis**, qui typiquement à l'origine d'une tuberculose pulmonaire

La tuberculose digestive est peu fréquente quand on la compare à la tuberculose pulmonaire

**Tuberculose abdominale** : tuberculose du tube digestif et de tout autre organe dans la cavité abdominale, à l'exception de la tuberculose œsophagienne.

**Tuberculose intestinale** : tuberculose non péritonéale du tube digestif.

**Tuberculose péritonéale** : tuberculose du péritoine.

## **2. Intérêt de la question :**

Double problème

1- Diagnostic

**Positif = qui est difficile**

- Vu - La présentation clinique **peu spécifique**.
- Nature insidieuse de la maladie.
- Marqueurs biologiques et la radiologie : **non spécifiques**.
- Difficulté de l'exploration du grêle.
- Recours fréquent à un geste invasif : laparoscopie, mini-laparotomie, Bx transcutanées guidées par Imagerie.

**Différentiel** = maladie de crohn +++, carcinose.

2- Thérapeutique → traitement médical efficace que sur les lésions inflammatoires

# **II. Épidémiologie :**

- Incidence élevée en inde, la chine mais plus marquée en Afrique du sud (co-infection VIH)
  - Fréquence : - La tuberculose abdominale : 10 % des TEP.
    - TB intestinale : 0.1 a 0,7% toutes localisation.
    - TB péritonéale : 1.5 a 3% toutes localisation
- Elle reste la forme abdominale la plus fréquente: 31-58%.

- Autres données épidémiologiques :

À tout âge; mais on note un âge moyen : **35 – 45 ans**.

Sex-ratio : H/F = **1**

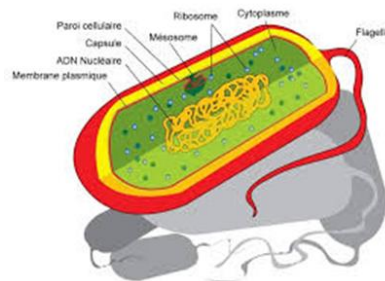
Groupes à risque

- **Migrants** en provenance de pays à forte prévalence
- Patients infectés par le **VIH**
- Population **carcérale**

## III. Etiopathogénie

### 1- L'agent pathogène

- Les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis: M.tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. caprae, M. microti, M. pinnipedi, ect...
- Le bacille de Koch est une mycobactérie de 2 à 5 µm de longueur, **immobile** très **sensible** à la chaleur mais **résistante** au froid et à la dessiccation,
- Colorée en rouge par la fuchsine, **non décolorée** par l'acide Nitrique ou l'alcool d'où la nomination de bacille acido-alcool-résistant (**BAAR**).
- Il se cultive en aérobie stricte entre 35et37°C sur milieux enrichis notamment celui de **Löwenstein-Jensen**.



### 2- Mode de contamination

Par voie digestive

- Déglutition des crachats (TBC pulm évolutive)
- Ingestion de lait de vache contaminé

Hématogène

Lymphatique (TBC gang)

Extension de voisinage (TBC péritonéale ou génitale)

### 3- Facteurs favorisants

- Groupe à prévalence élevée : la précarité, la toxicomanie, le diabète, le grand âge la dénutrition, l'immigration de pays en zone de forte endémie

- Groupe à risque élevé : l'infection par le VIH, la présence d'une cirrhose, la présence d'une IRC, la corticothérapie prolongée, Anti-TNF

## IV. Tuberculose intestinale

- localisation du bacille de Kock (BK) au niveau de l'intestin responsable de processus inflammatoire.
- Peut intéresser toutes les portions du tube digestif
- **la région iléo-cæcale** : siège préférentiel (la stase physiologique, Richesse en tissu lymphatique).

### A. Mode de contamination :

- **Primitive** : 60-70%: sujet indemne de TBC
  - M.Tuberculosis (BK): aliments souillés
  - M.Bovis : lait non pasteurisé
- **Secondaire** : digestive (inhalation), hémotogène, lymphatique, extension.

### B. Anatomopathologie :

Macroscopie : forme hypertrophique, ulcéreuse, ulcéro-hypertrophique.

Microscopie :

**1- Lésion spécifique caractéristique** : le **granulome tuberculoïde** qui semble prendre naissance dans la muqueuse.

#### **2- Lésions non spécifiques :**

- La nécrose caséeuse au centre du granulome : valeur Dc +++ , mais elle n'est ni constante ni spécifique
- Au fil du temps, la fibrose apparaît, puis s'étendant de la sous-muqueuse à la musculuse
- Œdème
- Infiltrat cellulaire polymorphe

### C. Manifestations cliniques TDD : Tuberculose iléo-cæcale non compliquée

- **Interrogatoire** : vaccination BCG, le contact tuberculeux, déficit immunitaire
- **Signes généraux** : anorexie, amaigrissement, asthénie, fièvre, sueurs nocturnes
- **Signes fonctionnels** : **douleurs abdominales** (FID), nausées, vomissements  
**Troubles de transit (diarrhée)**, Syndrome de Koenig (sténose).
- **Signes physiques** : Examen normal dans 2/3 des cas
  - Masse ferme, sensible, mal limitée (FID)
  - Ascite associée
  - Examen lympho-ganglionnaire systématique

### D. Examens para cliniques

## 1. Biologie

**Bilan standard** (retentissement) : anémie inflammatoire, VS accélérée, **Syndrome carentiel** (lésions étendue)

**IDR** : - positive dans 30 % (négative n'exclut pas le diagnostic, positive n'est pas spécifique d'une tb actif)

- Son interprétation varie selon le statut immunitaire

**Recherche de BK** : aspiration gastrique, biopsie (ex direct, culture, PCR)

**Tests de l'interféron Gamma** :

Tests quantitatifs qui évaluent la réponse immunitaire, Sensibilité de 89% pour le diagnostic des formes **latentes** de tuberculose péritonéale

Positif > 3,2 UI / ml.

**Test de la Polymérase Chain Réaction (PCR)**

Test rapide permettant d'isoler le BK entre 24 et 48h

Coût élevé

## 2. Radiologie

**Télé thorax** : localisations pulmonaires anciennes ou évolutives

**ASP** : - Calcifications (ADP)

- NHA (syndrome occlusif)
- Grisaille diffuse (ascite)

**Echo et TDM abdomino-pelviennes**

- ADP à centre clair ou calcifiées
- Epaissement intestinal
- Stase = sténose

**Iléo coloscopie** : Ulcérations, rétraction caecale, aspect polypoïde, sténose, réalisation des biopsies.

**Transit du grêle** :

- Stade du début

Atteinte folliculaire (rare) → nodule d'alarme de Marina Fiol

- Stade +/- tardif

Ulcération

Signe de Stierlin (absence d'opacification du CD)

- Stade tardif : lésions ulcéro-hypertrophiques

## E. Formes cliniques

**Les formes topographiques** :

- TBC duodénale
- TBC appendiculaire :

- TBC rectale
- TBC anale

#### Les formes compliquées :

- Occlusion intestinale : ++fréquente
- Hémorragie
- Perforation
- Malabsorption

## V. Tuberculose péritonéale

Infection de la séreuse péritonéale

Elle reste la forme abdominale la plus fréquente

#### A. Mode de contamination :

- Rupture d'un ganglion mésentérique infecté
- à partir des lésions des organes avoisinants (génitale, intestinale)
- Concomitante avec une miliaire TB.

#### B. Anatomopathologie :

Macroscopie :

- **formes granuliques** : granulations jaunâtres ou blanchâtres de 0,5 à 2 mm de diamètre de taille, uniformément réparties sur le **péritoine (en grain de couscous)**; sur le foie, la rate, l'intestin grêle, le diaphragme et les annexes ; elles peuvent se **calcifier** ; ou devenir **volumineuses**.

- **formes ascitiques** : l'épanchement liquidien s'associe à une granulation miliaire.

- **formes fibro-adhésives** :

la fibrose envahit les granulations avec formation de brides et de lames de fibrose qui étranglent l'intestin.

Microscopie : même lésions que la tb intestinale

#### C. Manifestations cliniques

TDD : ascite essentielle

Même tableau clinique observé dans la tb intestinal, sauf que les signes physiques sont dominés par la distension abdominale (**Ascite**)

#### D. Examens para cliniques

##### 1- Biologie

Ponction d'ascite exploratrice : (examen de 1ere intention)

- Aspect macroscopique : souvent citrin.
- étude biochimique : Protéines >25 g/l, GASA<11 (ascite exsudative)
- étude cytologique : Prédominance lymphocytaire, absence de cellule maligne
- étude bactériologique : recherche de BK (coloration de **ZiehlNeelsen**, Culture milieu de **Löwenstein–Jensen**).

Adénosine désaminase (ADA) : dans l'ascite (examen clé)

- Enzyme impliquée dans la prolifération et la différenciation des lymphocytes T.
- **Dosage > 35 UI/L**; sensibilité 100%, spécificité 96%.

## 2- Radiologie

### Echographie

Elle permet d'aider DC +:

#### 1- L'ascite :

- Cloisonnée ou libre
- L'importance.
- Filaments intra-ascitiques hyperéchogènes

#### 2- Les anomalies sous pariétales

- Des épaississements hypoéchogènes allongés, localisés soit diffus
- Des images nodulaires hyperéchogènes situées sur le péritoine pariétal et viscéral (difficiles à voir à l'échographie). Elles correspondent aux granulations péritonéales vues à la laparoscopie.

#### 3- Les ganglions : ADP supra cm, calcifiés.

Aider au DC différentiel

Permet également : Guider ponction et aspiration des adénomégales.

### TDM AP :

Visualise mieux les modifications du mésentère de l'épiploon et du péritoine.

N'est pas supérieur à l'échographie

## 3- Autre

### Laparoscopie :

- L'outil diagnostique de choix pour diagnostic de la tuberculose péritonéale : **Sensibilité : 93% (si ADA négative ou doute diagnostic)**
- Réalisation de **biopsies**.
- Étude de l'état du foie et des organes génitaux.

### Laparotomie exploratrice :

- En cas de **CI à la laparoscopie** (les formes fibro-adhésives et ulcéro-nécrotiques).



## VI. Autres atteintes

- **Estomac** : Ulcération gastrique, Épaississement gastrique, Sténose antro-pylorique
- **Foie** : Cholestase anictérique, Une hépatomégalie, Abscès, Nodule (foie multinodulaire)
- **Pancréas** : Masse pancréatique.

## VII. Diagnostic différentiel

### 1. Devant une ascite exsudative et/ou lymphocytaire, éliminer :

- carcinose péritonéale.
- ascite pancréatique.
- SBC aigue
- myxoédème.
- ascite due à une obstruction intestinale ou un infarctus mésentérique.
- vascularites

### 2. Devant un épaississement ou ulcération colique, éliminer :

- **Maladie de Crohn** (iléo-caecale) : deux pathologies du sujet jeune, diagnostic différentiel le plus difficile (même histologique)
- ADK colique
- Lymphome iléo-caecale
- Colite ischémique
- Appendicite pseudo-tumorale
- Sarcoïdose colique

## VIII. Traitement

### 1. BUT

- Éradication de BK: guérison de l'infection.
- TRT et prévention des complications

### 2. MOYENS

- Symptomatique.
- Spécifique : CMT antituberculeuse.
- Adjuvant :
  - CTC (fibrose)
  - Ponctions (ascite de grande abondance)

### 3. Indication

#### La Chimiothérapie Antituberculeuse

Les médicaments antituberculeux essentiels sont au nombre de cinq :

Isoniazide (H), Rifampicine (R), Pyrazinamide (Z), Streptomycine, Ethambutol (E)

| Association de médicaments (Abréviation)                    | Dosage par comprimé          |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                             | Adulte                       | Enfant              |
| Isoniazide + Rifampicine (HR)                               | 75mg + 150mg                 | 30mg + 60mg         |
| Isoniazide + Rifampicine + Pyrazinamide (HRZ)               | 75mg + 150mg + 400mg         | 30mg + 60mg + 150mg |
| Isoniazide + Rifampicine + Ethambutol (HRE)                 | 75mg + 150mg + 275mg         | ----                |
| Isoniazide + Rifampicine + Pyrazinamide + Ethambutol (HRZE) | 75mg + 150mg + 400mg + 275mg | ----                |

a) **Bilan pré-thérapeutique** : bilan hépatique, rénal, formule, sérologie VIH, avis ORL

b) **Schéma** : selon les nouvelles recommandation RHZ devient RHZE dans la tb intestinale

|     |                                                                                                |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| TEP | . Primo infection symptomatique sans opacité pulmonaire                                        | 2HRZ | 4 HR |
|     | . Formes communes de TEP (Adénopathies périphériques, Pleurésies, ascite, tuberculose osseuse) |      |      |

c) **Dose : selon le poids**

| POIDS   | RHZ 2MOIS | RH 4 mois |
|---------|-----------|-----------|
| 30 – 37 | 2         | 2         |
| 38 – 54 | 3         | 3         |
| 55 – 70 | 4         | 4         |
| >71     | 5         | 5         |

#### La chirurgie

Le traitement chirurgical est indiqué en cas de :

- Complications révélatrices : perforation, occlusion
- Diagnostic incertain après des explorations approfondies
- Sténose symptomatique après stérilisation de l'infection

## IX. Conclusion

- La TB demeure un problème de santé publique en Algérie.
  - La région iléocæcal : localisation la plus importante de la tuberculose intestinale.
  - Le principal diagnostic différentiel de la TBI est la maladie de Crohn.
  - dosage de l'ADA test rapide, excellente sensibilité et spécificité pour le diagnostic de la TBP.
- Il devrait être utilisé de façon courante dans les pays endémiques.
- Les biopsies péritonéales (laparoscopique) : confirme le diagnostic
  - Le traitement de la tuberculose intestinale et péritonéale est essentiellement médical
  - Le traitement chirurgical est réservé aux complications